

现。所以每种新氟喹诺酮类药物在早期的临床应用时进行安全性监测是值得推荐的事。

Norrby SR等《Drugs》1993; 45(Suppl 3):59(英文)

徐积恩摘

15-67 氟喹诺酮在肠内吸收期的药物相互作用

氟喹诺酮抗菌药已在世界范围内用于治疗严重感染。本文作者综述不同喹诺酮在吸收期的药物相互作用。主要讨论环丙沙星和氧氟沙星等与食物、H₂受体拮抗剂、抗胆碱能药物和含金属阳离子药物的相互作用。

食物(标准早餐)、H₂受体拮抗剂和抗胆碱能药物对喹诺酮药物的生物利用度无大的影响,但抗酸剂、硫酸亚铁和其他含金属阳离子的药物可降低喹诺酮的生物利用度。其机制是喹诺酮分子中的功能团与金属阳离子间的整合作用,产生不溶性复合物,此复合物不能为肠道吸收。不同的喹诺酮抗菌药,它们的生物利用度降低程度也不同。

Deppermann KM《Drugs》1993; 45(Suppl 3); 65(英文)

徐积恩摘

15-68 喹诺酮类抗菌药防治免疫缺陷患者的感染

恶性血液病患者防治感染是一个重要问题。氟喹诺酮类的抗菌谱广,对中性粒细胞减少患者,诺氟沙星可使革兰阴性菌感染率减少,但对革兰阳性菌和真菌感染没有影响。氧氟沙星和依诺沙星也可使这些患者的发烧和感染性疾病减少。在一随机研究中,对比环丙沙星和复方新诺明加多粘菌素E,发现环丙沙星可预防革兰阴性菌感染的发生,但革兰阳性菌感染明显增加。环丙沙星联用大环内酯抗生素预防链球菌感染可产生耐药革兰阳性致病菌的暴发性菌血症。

在肿瘤患者治疗感染的标准治疗常用静注喹诺酮和氨基糖甙抗生素。这种联合治疗

的临床试验表明有上述同样的效果。单用环丙沙星比标准联合治疗的有效率差。因此对发热中性粒细胞减少患者不推荐喹诺酮类抗菌药的单药治疗。

Maschmeyer G《Drugs》1993; 45(Suppl 3); 73(英文)

徐积恩摘

15-69 环孢素与硫酸镁在5%葡萄糖注射液中的稳定性

环孢素为一强免疫抑制剂,主要用于预防和治疗同种异体肾、肝及心脏器官移植后的排斥反应。

本文研究旨在测定环孢素和硫酸镁在5%葡萄糖注射液中贮存于室温(24℃)36h的配伍稳定性。

方法 在装有50%硫酸镁注射液6ml和5%葡萄糖注射液90ml的250ml玻璃瓶中加入50mg/ml环孢素4ml,混合后环孢素和硫酸镁的浓度分别为2.0mg/ml和30mg/ml,采用传统的灭菌技术配制,样品一式三份,贮存在室温(24.0±2.4℃)、荧光下,于0、6、12、24和36h取样,检查颜色变化,混浊或沉淀,同时采用HPLC法测定环孢素浓度。

结果 当环孢素和硫酸镁混合后则立即产生混浊,但这种混浊现象大概在30s内就消失了,样品没有颜色变化或产生沉淀。测得混合液中的环孢素在6、12、24和36h内的浓度分别为初浓度的(95.4±1.6)%、(90.4±0.8)%、(90.9±1.7)%和(93.4±0.7)%。

由此可见,2.0mg/ml环孢素和30mg/ml硫酸镁与5%葡萄糖注射液混合在玻璃瓶中,贮存在室温、荧光下,环孢素在6h内是稳定的。

Keith A等《Am J Hosp Pharm》1993; 50:470(英文)

习贵权摘 溪念朱校